



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 15:16

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: CC 73085014 - DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES

Fecha de Nacimiento: 25/05/1960

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BARRIO LOS CALAMARES MZ 25 LOTE 56

Teléfono:

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO

OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante: ESTA SOLO

Teléfono Acomp.:

Dirección Acomp.:

Responsable:

Teléfono Resp.:

Dirección Resp.:

Médico Tratante: ARIEL ALONSO BELLO ESPINOSA

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Fecha de Atención: 02/04/2024 13:24

Admisión: AD939876

Edad: 63 año(s), 10 mes(es) 8 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.:

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Impreso por: AMRANDA

Sexo: M

Estado Civil:

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 26/03/2024 16:05

Cama: 4--17

Motivo de la Consulta:

"ESTA VOMTANDO SANGRE Y TIENE MUCHA TOS"

ANTECEDENTES:

* 1-> HTA Y DM TIPO II MAL CONTROLADA

* 5-> NIEGA

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS CON CC DE LARGA DATA CARACTERIZADO POR TOS PRODUCTIVA, HEMOPTISIS, DISNEA, PERDIDA DE PESO, FEBRE Y ESCALOFRÍOS.

Paciente masculino en su 7ma década de la vida con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2; actualmente hospitalizado en contexto de 1. Neumonía adquirida en la comunidad, 2 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente. Se inició Terapia RIPE, hoy en su cuarto día efectivo además en su quinto día de ampicilina sulbactam y de claritromicina con mejoría clínica significativa con respecto al ingreso. Cuenta con transaminasas en valores normales.

Actualmente por el servicio de medicina interna debido a la satisfactoria evolución clínica y que el paciente cuenta con la posibilidad de aislamiento en casa se decide dar alta, con manejo ambulatorio, a nivel metabólico aun con rangos de glucometrías por debajo de metas, se considera ante paciente con sensibilidad a insulina y riesgo de hipoglucemias, suspender insulinas y continuar manejo en casa con metformina y cita control en 15 días con medicina interna e infectología con control de aminotransferasas. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Revisión Por Sistema:

RESPIRATORIOS

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

ALERTA, AFEBRIL, HIDRATADO, COLABORADOR, DEAMBULANDO

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO, CABELLOS NORMOIMPLANTADOS PABELLON AURICULAR NORMOCONFIGURADO Y BIEN IMPLANTADO A LA OTOSCOPIA ALTERACIONES PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVA A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA OROFARINGE NORMAL CUELLO MOVIL SIN MASAS NI ADENOPATIAS PALPABLES.

Tórax:

SIMETRICO EXPANDIBLE, TIRAJES SUBCOSTALES EN HEMITORAX IZQUIERDO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS DE BUEN TONO SIN SOPLOS AUDIBLES, CAMPOS PULMONARES CON MURMULLO VESICULAR PRESENTE CON CREPITOS EN IZQUIERDA.

Abdomen:

BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, SIN MASAS NI MEGALIAS PALPABLES, NO DATOS DE IRRITACION PERITONEAL PERISTALTIS POSITIVA

Piel y faneras:

ANICTERICA, HIDRATADA, SIN LESIONES EVIDENTES.

Genito-Urinario:

NO EXPLORADO

Extremidades:

SIMETRICAS, EUTROFICAS, SIN EDEMAS NO CIANOSIS, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEGUNDOS.

Sistema nervioso central:

CONSCIENTE ORIENTADO, SIN DEFICIT SENSITIVO O MOTOR APARENTE, SIN FOCALIZACION NEUROLOGICA

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS CON ANT DE HTA Y DM TIPO II CON MALA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, QUE INGRESA POR CC DESCRITO. AL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:14:47 p. m.

Admisión: AD939876

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: DIGNO DE JESUS MORALES BENAMDES

EPICRISIS

EXAMEN FISICO ALERTA/AFEBRIL HIDRTDA CON DETERIORO MUSCULO ESQUELETICO, CON TAQUIPNEA Y TAQUICARDIA, SATURACIONES LIMITROFES, CON TIRAJES SUBCOSTALES DE PREDOMINIO EN HEMITORAX IZQUIERDO, CON CREPITO EN BASE IZQUIERDA, RESTO DE EXAMEN SIN ALTERACIONES. PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS, POR LO CUAL SE INGRESA TOMA DE LABORATORIOS, IMAGENES Y SE DA MANEJO CON BRONCODILATADORES.

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal: R042 : HEMOPTISIS

Diagnóstico Relacionado 1: J069 : INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA

EVOLUCIONES:

Fecha: 26/03/2024: 22:02:21, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: RAFAEL DE JESUS BORRE GUERRERO, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Problema:

IDX:

1. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD?
2. ANEMIA NORMOCITICA HIPOCROMICA
3. HIPERTENSION ARTERIAL POR AP
4. CRISIS HIPERGLUCEMICA
- DIABETES MELLITUS TIPO II POR AP

Subjetivo:

EA:

PACIENTE DE SEXO MASCULINO DE 63 AÑOS CON CUADRO CLINICO DE LARGA DATA CARACTERIZADO POR TOS PRODUCTIVA, HEMOPTISIS, DISNEA, PERDIDA DE PESO, FIEBRE Y ESCALOFRÍOS.

Objetivo:

EF:

TORAX SIMETRICO EXPANDIBLE, TIRAJES SUBCOSTALES EN HEMITORAX IZQUIERDO, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS DE BUEN TONO SIN SOPLOS AUDIBLES, CAMPOS PULMONARES CON MURMULLO VESICULAR PRESENTE CON CREPITOS EN IZQUIERDA.

PARACLINICOS:

GLUCOSA EN SUERO.....: 428 mg/dl

CREATININA EN SUERO.....: 0.97 mg/dl

NITRÓGENO UREICO (BUN).....: 14 mg/dl

POTASIO EN SUERO.....: 5.4 mmol/L

SODIO EN SUERO: 131 mmol/L

CALCIO IÓNICO.....: 1.15 mmol/l

CORO EN SANGRE.....: 95 mmol/L

TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA (ALT): 101 U/L

TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA (AST): 105 U/L

Albúmina en Sangre.....: 3.21 gr/dl

DESHIDROGENASA LÁCTICA.....: 214 U/l

Bilirrubina Total: 0.70 mg/dl

Bilirrubina Directa: 0.25 mg/dl

Bilirrubina Indirecta: 0.45 mg/dl

HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO

LEUCOCITOS $9.91 \times 10^3/\text{mm}^3$ 4.0 11.0

NEUTROFILOS% 82.1 % 45.0 75.0

NEUTROFILOS# $8.13 \times 10^3/\text{mm}^3$ 4.50 7.00

LINFOCITOS% 10.6 % 20.0 45.0

LINFOCITOS# $1.05 \times 10^3/\text{mm}^3$ 1.50 4.50

MONOCITOS% 6.4 % 1.00 8.00

MONOCITOS# $0.63 \times 10^3/\text{mm}^3$ 0.00 0.80

EOSINOFILOS% 0.14 % 1.00 6.00

EOSINOFILOS# $0.01 \times 10^3/\text{mm}^3$ 0.00 0.45

BASOFILOS% 0.80 % 0.00 1.00

BASOFILOS# $0.08 \times 10^3/\text{mm}^3$ 0.00 0.20

ERITROCITOS $4.08 \times 10^6/\text{mm}^3$ 4.0 4.8

HEMOGLOBINA 10.3 gr/dl 12.0 16.0

HEMATOCRITO 33.0 % 36.0 48.0

INDICES HEMATICOS

Volumen Corpuscular Medio (VCM): 80.9 μm^3 80.0 100.0

Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 25.2 pg 26.5 32.0

Concentracion Hb.Corp.Med (CCMH): 31.1 gr/dl 32.0 36.0

Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 13.0 % 11.5 15.0

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas (PLT): $249 \times 10^3/\text{mm}^3$ 150 450

Volumen Plaquetario Medio (VPM): $6.30 \mu\text{m}^3$ 6.5 11.0

Plaquetocrito (PTC): 0.16 % 0.100 0.500

Ancho Distrib. de Pla. (PDW): 18.52 % 25 65

Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 Y 2 ANTICUERPOS

HIV I+II Anticuerpos [Anti-VIH]

Técnica: Inmunocromatografía

Anticuerpos HIV-1.....: NEGATIVO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:14:47 p. m.

Admisión: AD939876

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: DIGNO DE JESUS MORALES BENAMDES

EPICRISIS

Anticuerpos HIV-2.....: NEGATIVO

RADIOGRAFIA DE TORAX CON EVIDENCIA DE LESION DE LIMITADA DE ASPECTO CONSOLIDATIVO Y CAVERNOSO.

Análisis:

ANÁLISIS:

PACIENTE DE SEXO MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD QUIEN AL MOMENTO PRESENTA CUADRO RESPIRATORIO, QUIEN DE MOMENTO CUENTA CON VIH NEGATIVO, HIPERGLUCEMIA, TRANSAMNITIS, FUNCION RENAL CONSERVADA, BILIRRUBINAS CONSERVADAS, HIPERGLUCEMIA, HEMOGRAMA CON ANEMIA Y SIN TRASTORNOS PLAQUETARIOS Y/O LEUCOCITARIOS, CON RADIOGRAFIA DE TORAX CON EVIDENCIA DE LESION DE LIMITADA DE ASPECTO CONSOLIDATIVO Y CAVERNOSO. POR LO QUE INDICO CONTINUAR MANEJO MEDICO INDICADO Y SER VALORADO POR MEDICINA INTERNA SE LE EXPLICA ACEPTA Y ENTENDE.

Fecha: 27/03/2024: 10:01:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Paciente de 63 años con DX:

1. Tuberculosis pulmonar por diagnostico clínico y radiológico

2. Neumonía adquirida en la comunidad: CURB 65 - PSI

3. Anemia leve normocítica hipocrómica homogénea a estudio

4. Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

Subjetivo:

Paciente refiere haber pasado buena noche, continúa con hemoptisis, tolerando la vía oral

Objetivo:

Signos vitales: PA 114/75 mmHg, FC 84 lpm, FR 19 rpm, T 36.7°C, SpO2 96% con cánula nasal a 3L/min Peso: 54 Kg Talla 1.72

Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, tirajes subcostales de predominio en hemitorax izquierdo, murmullo vesicular universal presente crépitos en 2/3 inferiore de hemitorax derecho, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos.

Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

26/03/2024: Hemograma: Leucocitos: 9.910 neutrófilos: 8.130 linfocitos: 1.050 monocitos: 630 eosinófilos: 10 basófilos: 80 eritrocitos: 4.080 hemoglobina: 10.3 hematocrito: 33.0% VCM 80.9 HCM 25.2 CCMH: 31.1 IDE: 13.0 plaquetas: 249.000 VPM: 6.30 PTC: 8.16 PDW: 18.52 ALT: 101 AST: 105 bilirrubinas totales: 0.70 bilirrubina directa: 0.25 bilirrubina indirecta: 0.45 calcio: 1.15 BUN: 14 creatinina: 0.97 TFG **glucosa: 428** DHL: 214 potasio: 5.4 sodio: 131

VIH 1 Y2: Negativo

27-03-2024

HbA1c: 7.28

27-03-2024

TOMOGRAMIA DE TORAX SIMPLE

Técnica: Con Tomógrafo Multidetector se realizan cortes axiales desde el opérculo torácico hasta el abdomen superior en fase simple.

HALLAZGOS

En lo incluido de la base del cuello no se identifican hallazgos de interés patológico.

Vía aérea de calibre normal. No se observó lesión endoluminal o compresión extrínseca.

No observo masas ni adenopatías mediastinales.

Aorta torácica y vasos supraaórticos de calibre y curso normal.

Índice cardiotorácico normal. No hay líquido pericárdico.

En el parénquima pulmonar se evidencian pequeños nódulos centrilobulillares, opacidades lineales y nodulares ramificadas con diseminación broncogénica, así mismo extensas áreas de consolidaciones pulmonares bilaterales con áreas de cavitación asociadas de predominio en lobullos superiores, hallazgos en relación con TBC.

No observo líquido pleural ni neumotórax.

En las estructuras óseas se muestran con densidad normal. No se aprecian fracturas, tampoco lesiones líticas o blásticas.

Radiografía de tórax: 2 lesiones cavernosas en ápice pulmonar derecha, infiltrado consolidativo en base epulmonar derecha paracardiaco, lesión cavernosa en ápice izquierdo. (Pendiente reporte oficial)

Análisis:

Paciente masculino de 63 años de edad con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 con mala adherencia al tratamiento; actualmente en urgencias por disnea, tos con expectoración purulenta, pérdida de peso, sudoración nocturna y hemoptisis. Al examen físico en mal estado musculoesquelético y crepitos en hemitorax derecho. Paraclínicos de ingreso con anemia grado I de volúmenes normales e hiperglucemia. Rx de torax con lesiones cavitadas y consolidativas, se realiza tomografía de torax con evidencia de patrón en árbol de gemación, cavernas bilaterales en ambos ápices pulmonares, llama la atención ocupación de cavernas, por lo que no se descarta hallazgo de fungus ball. Se considera paciente con Neumonía adquirida en la comunidad con tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico, dado patrón tomográfico que muestra múltiples cavitaciones, debe continuar manejo antibiótico con ampicilina/subactam puesto que no se descarta sobreinfección, se inicia Terapia RIPE y se solicita valoración por neumología para descartar que hallazgos tomográfico no se deban a posible aspergiloma, se solicita galactomanano sérico, se solicitan pruebas de función hepática y renal para inicio de antifúngico. Por otra parte paciente con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, glicada fuera de metas, dadas glucometrías fuera de metas se ajusta esquema de insulino terapia, se solicitan gases arteriales, cetonas en sangre para descartar complicación aguda de la diabetes. Además paciente con anemia leve normocítica hipocrómica homogénea, se indica desparasitación, se solicita perfil ferocinético, reticulocitos, carencial y extendido de sangre periférica. Continúan pendientes PCR, Cultivo de esputo y baciloscopia para mycobacterium tuberculosis. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:14:47 p. m.

Admisión: AD939876

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: DIGNO DE JESUS MORALES BENAMDES

EPICRISIS

Fecha: 28/03/2024: 12:08:48, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Paciente de 63 años con DX:

1. Tuberculosis pulmonar por diagnostico clínico y radiológico
2. Neumonía adquirida en la comunidad: CURB 65: 0 puntos - PSI: 93 puntos
3. Anemia leve normocítica hipocrómica homogénea a estudio
4. Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche, niega dolor, malestar general, fiebre, mareos, vómitos u otra sintomatología asociada.

Objetivo:

Signos vitales: PA 114/75 mmHg, FC 84 lpm, FR 19 rpm, T 36.7°C, SpO2 96% con cánula nasal a 3L/min Peso: 54 Kg Talla 1.72 Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, tirajes subcostales de predominio en hemitorax izquierdo, murmullo vesicular universal presente crépitos en 2/3 inferiore de hemitorax derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

IMÁGENES:

28 27-03-2024 TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Técnica: Con Tomógrafo Multidetector se realizan cortes axiales desde el opérculo torácico hasta el abdomen superior en fase simple. HALLAZGOS En lo inducido de la base del cuello no se identifican hallazgos de interés patológico. Vía aérea de calibre normal. No se observó lesión endoluminal o compresión extrínseca. No observo masas ni adenopatías mediastinales. Aorta torácica y vasos supraaórticos de calibre y curso normal. Índice cardiotorácico normal. No hay líquido pericárdico. En el parénquima pulmonar se evidencian pequeños nódulos centrilobulillares, opacidades lineales y nodulares ramificadas con diseminación broncogénica, así mismo extensas áreas de consolidaciones pulmonares bilaterales con áreas de cavitación asociadas de predominio en lobullos superiores, hallazgos en relación con TBC. No observo líquido pleural ni neumotórax. En las estructuras óseas se muestran con densidad normal. No se aprecian fracturas, tampoco lesiones líticas o blásticas. Radiografía de tórax 2 lesiones cavemosas en ápice pulmonar derecha, infiltrado consolidativo en base epulmonar derecha paracardiaco, lesión cavemosa en ápice izquierdo.

Análisis:

Paciente masculino de 63 años de edad con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 con mala adherencia al tratamiento; actualmente en urgencias por disnea, tos con expectoración purulenta, pérdida de peso, sudoración nocturna y hemoptisis. Al examen físico en mal estado musculoesquelético y crépitos en hemitorax derecho. Paraclínicos de ingreso con anemia grado I de volúmenes normales e hiperglucemia. Rx de tórax con lesiones cavitadas y consolidativas, se realiza tomografía de tórax con evidencia de patrón en árbol de gemación, cavernas bilaterales en ambos ápices pulmonares, llama a la atención ocupación de cavernas, por lo que no se descarta hallazgo de fungus ball. Se considera paciente con Neumonía adquirida en la comunidad con tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico, dado patrón tomográfico que muestra múltiples cavitaciones, se continúa antibioticoterapia ya que no se descarta riesgo de sobreinfección, y reporte de baciloscopias que reporta positivo para BAAR (+++), se inicia Terapia RIPE. Se encuentra pendiente valoración por neumología para descartar que hallazgos tomográficos no se deban a posible aspergiloma. Pendiente de galactomanano sérico, función hepática y azoados para inicio de antifímico. Por otra parte paciente con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, glicada fuera de metas, dadas glucometrías fuera de metas se ajusta esquema de insulino terapia, cuenta con gases arteriales que reportan alcalosis respiratoria compensada, a la espera del reporte de cetonas en sangre para descartar complicación aguda de la diabetes. Anoche paciente realiza episodio hipoglucémico con glucometría control en 33mg/dl, por lo que se administra dextrosa con buena respuesta al manejo. Además paciente con anemia leve normocítica hipocrómica homogénea, ya en manejo con ivermectina. A la espera de perfil ferocinético, reticulocitos, carencial y extendido de sangre periférica. Continúan pendientes PCR, Cultivo de esputo y baciloscopia para mycobacterium tuberculosis. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 29/03/2024: 09:32:28, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Paciente de 63 años con DX:

1. Tuberculosis pulmonar por diagnostico clínico y radiológico
2. Neumonía adquirida en la comunidad: CURB 65: 0 puntos - PSI: 93 puntos
3. Anemia leve normocítica hipocrómica homogénea a estudio
4. Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche sin embargo refiere sentirse agitado, refiere fiebre, niega dolor, malestar general, fiebre, mareos, vómitos u otra sintomatología asociada.

Objetivo:

Signos vitales: PA 100/50 mmHg, FC 91 lpm, FR 17 rpm, T 36.7°C, SpO2 96% con cánula nasal a 3L/min Peso: 54 Kg Talla 1.72 Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, tirajes subcostales de predominio en hemitorax izquierdo, murmullo vesicular universal presente crépitos en 2/3 inferiore de hemitorax derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

IMÁGENES:

28 27-03-2024 TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Técnica: Con Tomógrafo Multidetector se realizan cortes axiales desde el opérculo torácico hasta el abdomen superior en fase simple. HALLAZGOS En lo inducido de la base del cuello no se identifican hallazgos de interés patológico. Vía aérea de calibre normal. No se observó lesión endoluminal o compresión extrínseca. No observo masas ni adenopatías mediastinales. Aorta torácica y vasos supraaórticos de calibre y curso normal. Índice cardiotorácico normal. No hay líquido pericárdico. En el parénquima pulmonar se evidencian pequeños nódulos centrilobulillares, opacidades lineales y nodulares ramificadas con diseminación broncogénica, así mismo extensas áreas de consolidaciones pulmonares bilaterales con áreas de cavitación asociadas de predominio en lobullos superiores, hallazgos en relación con TBC. No observo líquido pleural ni neumotórax. En las estructuras óseas se muestran con densidad normal. No se aprecian fracturas, tampoco lesiones líticas o blásticas. Radiografía de tórax 2 lesiones cavemosas en ápice pulmonar derecha, infiltrado consolidativo en base epulmonar derecha paracardiaco, lesión cavemosa en ápice izquierdo. (Pendiente reporte oficial)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:14:47 p. m.

Admisión: AD939876

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: DIGNO DE JESUS MORALES BENAMDES

EPICRISIS

Análisis:

Paciente masculino de 63 años de edad con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 con mala adherencia al tratamiento; actualmente en urgencias por disnea, tos con expectoración purulenta, pérdida de peso, sudoración nocturna y hemoptisis. Al examen físico en mal estado musculoesquelético y crepitos en hemitorax derecho. Paraclínicos de ingreso con anemia grado I de volúmenes normales e hiperglucemia. Rx de tórax con lesiones cavitadas y consolidativas, se realiza tomografía de tórax con evidencia de patrón en árbol de gemación, cavernas bilaterales en ambos ápices pulmonares, llama la atención ocupación de cavernas, por lo que no se descarta hallazgo de fungus ball. Se considera paciente con Neumonía adquirida en la comunidad con tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico, dado patrón tomográfico que muestra múltiples cavitaciones, se continúa antibioticoterapia ya que que no se descarta riesgo de sobreinfección, y reporte de dos baciloscopias que reporta positivo para BAAR (+++), se inicia Terapia RIPE. Ya valorado por el servicio de neumología quienes refieren que no requiere intervención ni llevar a paciente intrahospitalario en este momento para estudio de fibrobroncoscopia + lavado, continúa manejo médico tratante para estudio de TBC, para definir manejo y mejor alternativa terapéutica. Pendiente de galactomanano sérico, función hepática y azoados para inicio de antifímico. Por otra parte paciente con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, glicada fuera de metas, dadas glucometrías fuera de metas se ajusta esquema de insulino terapia, cuenta con gases arteriales que reportan alcalosis respiratoria compensada, a la espera del reporte de cetonas en sangre para descartar complicación aguda de la diabetes. Sin nuevos episodios nocturnos de hipoglucemia. Además paciente con anemia leve normocítica hipocrómica homogénea, ya en manejo con ivermectina. Continúan pendientes PCR, Cultivo de esputo y última baciloscopia para mycobacterium tuberculosis. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 30/03/2024: 10:31:02, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JAIME SARMIENTO CALDERON, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

Paciente de 63 años con DX:

1. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico
2. Neumonía adquirida en la comunidad: CURB 65: 0 puntos - PSI: 93 puntos
3. Anemia leve normocítica hipocrómica homogénea a estudio
4. Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche sin embargo refiere sentirse agitado, refiere fiebre, niega dolor, malestar general, fiebre, mareos, vómitos u otra sintomatología asociada.

Objetivo:

PA 90/50 mmHg, FC 88 lpm, FR 17 rpm, T 36.6°C, SpO2 96% con cánula nasal a 3L/min Peso: 54 Kg Talla 1.72 Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, tirajes subcostales de predominio en hemitórax izquierdo, murmullo vesicular universal presente crépitos en 2/3 inferior de hemitórax derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

IMÁGENES:

28-27-03-2024 TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Técnica: Con Tomógrafo Multidetector se realizan cortes axiales desde el opérculo torácico hasta el abdomen superior en fase simple. HALLAZGOS En lo inducido de la base del cuello no se identifican hallazgos de interés patológico. Vía aérea de calibre normal. No se observó lesión endoluminal o compresión extrínseca. No observo masas ni adenopatías mediastinales. Aorta torácica y vasos supraaórticos de calibre y curso normal. Índice cardiotorácico normal. No hay líquido pericárdico. En el parénquima pulmonar se evidencian pequeños nódulos centrilobulillares, opacidades lineales y nodulares ramificadas con diseminación broncogénica, así mismo extensas áreas de consolidaciones pulmonares bilaterales con áreas de cavitación asociadas de predominio en lobullos superiores, hallazgos en relación con TBC. No observo líquido pleural ni neumotórax. En las estructuras óseas se muestran con densidad normal. No se aprecian fracturas, tampoco lesiones líticas o blásticas. Radiografía de tórax: 2 lesiones cavernosas en ápice pulmonar derecha, infiltrado consolidativo en base epulmonar derecha paracardiaco, lesión cavernosa en ápice izquierdo. (Pendiente reporte oficial)

Análisis:

Paciente masculino de 63 años de edad con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 con mala adherencia al tratamiento; actualmente en urgencias por disnea, tos con expectoración purulenta, pérdida de peso, sudoración nocturna y hemoptisis. Al examen físico en mal estado musculoesquelético y crépitos en hemitorax derecho. Paraclínicos de ingreso con anemia grado I de volúmenes normales e hiperglucemia. Rx de tórax con lesiones cavitadas y consolidativas, se realiza tomografía de tórax con evidencia de patrón en árbol de gemación, cavernas bilaterales en ambos ápices pulmonares, llama la atención ocupación de cavernas, por lo que no se descarta hallazgo de fungus ball. Se considera paciente con Neumonía adquirida en la comunidad con tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico, dado patrón tomográfico que muestra múltiples cavitaciones, se continúa antibioticoterapia ya que que no se descarta riesgo de sobreinfección, y reporte de dos baciloscopias que reporta positivo para BAAR (+++), se solicita nuevamente PCR para mycobacterium tuberculosis y cultivo en esputo. Se inicia Terapia RIPE hoy en su segundo efectivo. Ya valorado por neumología quienes refieren que no requiere intervención ni llevar a paciente intrahospitalario en este momento para estudio de fibrobroncoscopia + lavado, continúa manejo médico tratante para estudio de TBC, para definir manejo y mejor alternativa terapéutica. Pendiente de galactomanano sérico, cuenta con transaminasas en el límite superior de la normalidad y azoados en metas. Por otra parte paciente con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, glicada fuera de metas, por lo que se ajusta esquema de insulino terapia, cuenta con gases arteriales que reportan alcalosis respiratoria compensada, con reporte de cetonas en sangre negativo, se descarta posible complicación aguda de diabetes. Sin nuevos episodios nocturnos de hipoglucemia, con mejoría en control metabólico. Además paciente con anemia leve normocítica hipocrómica homogénea, ya en manejo con ivermectina. Continúan pendientes PCR, Cultivo de esputo. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 31/03/2024: 09:54:55, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JAIME SARMIENTO CALDERON, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

Paciente de 63 años con DX:

1. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico
2. Neumonía adquirida en la comunidad: CURB 65: 0 puntos - PSI: 93 puntos
3. Anemia leve normocítica hipocrómica homogénea a estudio
4. Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche, refiere mejoría de deposiciones, refiere fiebre, niega dolor, malestar general, fiebre, mareos, vómitos u otra sintomatología asociada.

Objetivo:

Signos vitales:

PA 130/80 mmHg, FC 108 lpm, FR 22 rpm, T 36°C, SpO2 96% con cánula nasal a 3L/min Peso: 54 Kg Talla 1.72 Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:14:47 p. m.

Admisión: AD939876

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: DIGNO DE JESUS MORALES BENAMDES

EPICRISIS

oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, tirajes subcostales de predominio en hemitórax izquierdo, murmullo vesicular universal presente crépitos en 2/3 inferior de hemitórax derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

IMÁGENES:

28-27-03-2024 TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Técnica: Con Tomógrafo Multidetector se realizan cortes axiales desde el opérculo torácico hasta el abdomen superior en fase simple. HALLAZGOS En lo inducido de la base del cuello no se identifican hallazgos de interés patológico. Vía aérea de calibre normal. No se observó lesión endoluminal o compresión extrínseca. No observo masas ni adenopatías mediastinales. Aorta torácica y vasos supraaórticos de calibre y curso normal. Índice cardiotorácico normal. No hay líquido pericárdico. En el parénquima pulmonar se evidencian pequeños nódulos centrilobulillares, opacidades lineales y nodulares ramificadas con diseminación broncogénica, así mismo extensas áreas de consolidaciones pulmonares bilaterales con áreas de cavitación asociadas de predominio en lobullos superiores, hallazgos en relación con TBC. No observo líquido pleural ni neumotórax. En las estructuras óseas se muestran con densidad normal. No se aprecian fracturas, tampoco lesiones líticas o blásticas. Radiografía de tórax: 2 lesiones cavernosas en ápice pulmonar derecha, infiltrado consolidativo en base epulmonar derecha paracardiaco, lesión cavernosa en ápice izquierdo. (Pendiente reporte oficial)

Análisis:

Paciente masculino de 63 años de edad con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 con mala adherencia al tratamiento; actualmente en urgencias por disnea, tos con expectoración purulenta, pérdida de peso, sudoración nocturna y hemoptisis. Al examen físico en mal estado musculoesquelético y crépitos en hemitórax derecho. Paraclínicos de ingreso con anemia grado I de volúmenes normales e hiperglucemia. Rx de tórax con lesiones cavitadas y consolidativas, se realiza tomografía de tórax con evidencia de patrón en árbol de gemación, cavernas bilaterales en ambos ápices pulmonares, llama la atención ocupación de cavernas, por lo que no se descarta hallazgo de fungus ball. Se considera paciente con Neumonía adquirida en la comunidad con tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico, dado patrón tomográfico que muestra múltiples cavitaciones, se continúa antibioterapia ya que no se descarta riesgo de sobreinfección, y reporte de dos baciloscopias que reporta positivo para BAAR (+++), a la espera del reporte de PCR para mycobacterium tuberculosis y cultivo en esputo. Se inicia Terapia RIPE hoy en su segundo día efectivo. Ya valorado por neumología quienes refieren que no requiere intervención ni llevar a paciente intrahospitalario en este momento para estudio de fibrobroncoscopia + lavado, continúa manejo médico tratante para estudio de TBC, para definir manejo y mejor alternativa terapéutica. Pendiente de galactomanano sérico. Cuenta con transaminasas en el límite superior de la normalidad, por lo que se solicita control de transaminasas. Por otra parte paciente con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, glicada fuera de metas, por lo que se ajusta esquema de insulino terapia, cuenta con gases arteriales que reportan alcalosis respiratoria compensada, con reporte de cetonas en sangre negativo, se descarta posible complicación aguda de diabetes, glucometrías fuera de metas, aun con regular control metabólico, sin nuevos episodios nocturnos de hipoglucemia. Además paciente con anemia leve normocítica hipocrómica homogénea, ya en manejo con ivermectina. Continúan pendientes PCR, Cultivo de esputo. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 01/04/2024: 13:55:07, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Paciente de 63 años con DX:

1. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico
2. Neumonía adquirida en la comunidad: CURB 65: 0 puntos - PSI: 93 puntos
3. Anemia leve normocítica hipocrómica homogénea a estudio
4. Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche, con buenas deposiciones, niega fiebre, niega dolor, malestar general, fiebre, mareos, vómitos u otra sintomatología asociada.

Objetivo:

Signos vitales:

PA 130/80 mmHg, FC 108 lpm, FR 22 rpm, T 36°C, SpO2 96% con cánula nasal a 3L/min Glucometrías 01-04-2024 en ayunas 145 mg/dl. Peso: 54 Kg Talla 1.72 Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, tirajes subcostales de predominio en hemitórax izquierdo, murmullo vesicular universal presente crépitos en 2/3 inferior de hemitórax derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Análisis:

Paciente masculino en su 7ma década de la vida con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 con mala adherencia al tratamiento; actualmente en contexto de 1. Neumonía adquirida en la comunidad, 2 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente, no hay paraclínicos nuevos para reportar, Se inició Terapia RIPE hoy en su cuarto día efectivo además en su cuarto día de ampicilina sulbactam. Ya valorado por neumología quienes refieren que no requiere intervención ni llevar a paciente intrahospitalario en este momento para estudio de fibrobroncoscopia + lavado, continúa manejo médico tratante para estudio de TB, para definir manejo y/o alternativa terapéutica. Pendiente de galactomanano sérico. Cuenta con transaminasas en el límite superior de la normalidad, por lo que se solicita control de transaminasas. aun con regular control metabólico, por lo que se decide tomar glucometrías en horas de la madrugada ya que el paciente refiere episodios de hipoglucemia asintomática. Continúan pendientes PCR, Cultivo de esputo. Actualmente por el servicio de medicina interna a la espera de cumplir 5 días de antibioterapia para definir posible alta médica. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 02/04/2024: 13:08:45, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico y radiológico
2. Neumonía adquirida en la comunidad: CURB 65: 0 puntos - PSI: 93 puntos
3. Anemia leve normocítica hipocrómica homogénea a estudio
4. Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche, con buenas deposiciones, niega fiebre, niega dolor, malestar general, fiebre, refiere mareos y sudoración, vómitos u otra sintomatología asociada.

Objetivo:

Signos vitales:

PA 110/66 mmHg, FC 96 lpm, FR 19 rpm, T 36°C, SpO2 96% con cánula nasal a 3L/min Glucometrías 01-04-2024 en ayunas 145 mg/dl. Peso: 54 Kg Talla 1.72

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:14:47 p. m.

Admisión: AD939876

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: DIGNO DE JESUS MORALES BENAMDES

EPICRISIS

Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, tirajes subcostales de predominio en hemitórax izquierdo, murmullo vesicular universal presente crepitos en 2/3 inferior de hemitórax derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal, glucometrías con evidencias de hipoglicemia y fenómeno de Somogy.

Paraclínicos:

01-04-2024: LEU: 10.06 NEU: 7,22 LINF: 1,97 MONO: 0,62 HB: 10 HCTO: 31,8 VCM: 80 HCM: 25,3 PLT: 382 // ALT: 15 AST: 23

27/04/24 Galactomanano serico: negativo

Análisis:

Paciente masculino en su 7ma década de la vida con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2; actualmente hospitalizado en contexto de 1. Neumonía adquirida en la comunidad, 2 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente. Se inició Terapia RIPE, hoy en su cuarto día efectivo además en su quinto día de ampicilina sulbactam y de claritromicina con mejoría clínica significativa con respecto al ingreso. Cuenta con transaminasas en valores normales. Actualmente por el servicio de medicina interna debido a la satisfactoria evolución clínica y que el paciente cuenta con la posibilidad de aislamiento en casa se decide dar alta, con manejo ambulatorio, a nivel metabólico aun con rangos de glucometrías por debajo de metas, se considera ante paciente con sensibilidad a insulina y riesgo de hipoglicemias, suspender insulinas y continuar manejo en casa con metformina y cita control en 15 días con medicina interna e infectología con control de aminotransferasas. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir quienes refieren entender y aceptar.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Medidas Generales Ordenadas:

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

Complicaciones:

NIGUNA

Servicio de Egreso: 000014|Hospitalización 4to Piso

Fecha de Egreso: 02/04/2024 13:23

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: J189 : NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 1: A161 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, SIN EXAMEN BACTERIOLOGICO E HISTOLOGICO

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR

MEDICINA:

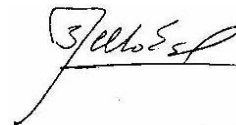
Tratamiento Farmacológico:

EL INDICADO EN PLAN

Recomendaciones Adicionales:

ASISTIR A SEGUIMIENTO MEDICO

Aplica Cuidados de Enfermería: No



ARIEL ALONSO BELLO ESPINOSA

MEDICINA INTERNA

CC.73094962 - RM.RM 0014 - CC 73094962